

TEMA 7.2 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Psiquiatría Infantil: TDA e Discapacidad Intelectual

PERFIL EUNACOM 5.01.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Trastorno por Déficit Atencional (TDAH)

El **Trastorno por Déficit Atencional (TDAH)** es una condición del neurodesarrollo que se enmarca dentro de la **neurodiversidad**. Su etiología es fundamentalmente **genética**, observándose con gran frecuencia antecedentes familiares directos.

Se caracteriza por una dificultad persistente para mantener el foco de atención, lo que impacta significativamente en el funcionamiento académico, social y laboral.

Presentación Clínica y Diagnóstico

La edad escolar es el momento más frecuente de diagnóstico, ya que las exigencias del sistema educativo ponen de manifiesto las dificultades del niño. El síntoma cardinal es el **cambio frecuente del foco de atención** (por ejemplo, el niño intenta estudiar, pero se distrae con cualquier estímulo irrelevante, como una mosca, y le cuesta retomar la tarea).

Existen dos subtipos principales de presentación:

TABLA 7.2.1: SUBTIPO VS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

SUBTIPO	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS	PERCEPCIÓN SOCIAL
Hiperactivo-Impulsivo	Inquietud motora constante, verborrea (habla mucho), impulsividad.	Fácil de identificar por la disrupción conductual.
Inatento (Hipoactivo)	Dificultad para concentrarse, parece estar "en las nubes", desorganizado.	Suele "pasar piola" (pasa desapercibido), diagnosticándose solo por el mal rendimiento.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En Chile, el subtipo inatento es el que más frecuentemente se subdiagnostica. Si un niño tiene **mal rendimiento escolar** pero se porta "bien" (está tranquilo en su puesto), siempre se debe sospechar un TDAH de predominio inatento.

TDAH en el Adulto

- El TDAH no desaparece necesariamente en la adultez; es una condición **crónica**. En los adultos, la clínica se manifiesta como:
- Mal rendimiento académico en la educación superior.
- Ineficiencia laboral o errores por descuido.
- Impulsividad** y falta de autocontrol.
- Desorden generalizado en la vida diaria.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Diagnóstico Diferencial Crítico: No confundir el TDAH con un episodio de **Manía** en el contexto de un **Trastorno Bipolar**. - El **TDAH** es crónico (el paciente siempre ha sido así desde la infancia). - La **Manía** es un cuadro agudo/episódico que incluye ánimo exaltado e ideas de grandiosidad, síntomas que no son propios del TDAH.

Manejo Terapéutico

El enfoque debe ser siempre **multidisciplinario**. El objetivo no es solo mejorar las notas, sino desarrollar habilidades para la vida.

- Técnicas de estudio y organización:** Adaptaciones ambientales y metodológicas.
- Manejo de autoestima:** Refuerzo positivo para compensar la frustración acumulada.
- Desarrollo de habilidades:** Entrenamiento en autocontrol y tolerancia a la frustración.

- Farmacoterapia:** Se reserva para casos donde el impacto funcional es moderado-severo.

TABLA 7.2.2: FÁRMACOS COMUNES VS TIPO

FÁRMACOS COMUNES	TIPO
Metilfenidato	Estimulante (el más utilizado).
Anfetaminas	Estimulante.
Modafinilo	Promotor de la vigilia (uso menos frecuente en niños).

Discapacidad Intelectual (DI)

Antiguamente denominada "retraso mental", la **Discapacidad Intelectual** se define por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa.

NOTA CLÍNICA

La etiología de la DI es multifactorial e incluye: - **Causas Genéticas:** (ej. Síndrome de Down, X Frágil). - **Causas Perinatales:** Asfixia neonatal, prematuridad extrema. - **Infecciones:** Complejo **TORCH** durante el embarazo. - **Causas Postnatales:** Traumatismos, infecciones del SNC.

Diagnóstico y Evaluación

- El diagnóstico se basa en pruebas estandarizadas de desarrollo y cognición.
- Coefficiente Intelectual (CI):** Un CI **menor a 70** se asocia tradicionalmente al diagnóstico, aunque es un indicador insuficiente por sí solo.
- Evaluación Funcional:** Es fundamental evaluar la capacidad del niño para el lenguaje, la lectura, las matemáticas y las funciones ejecutivas.

El manejo es multidisciplinario y se enfoca en la **estimulación temprana** y el apoyo educativo específico para las dificultades particulares de cada individuo.

Parálisis Cerebral (PC)

La **Parálisis Cerebral** es un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, que son atribuidos a alteraciones no progresivas que ocurrieron en el desarrollo del cerebro fetal o infantil.

EUNACOM CRITERIOS

Regla del 80/20 en Parálisis Cerebral: - El **80%** de los pacientes con PC tiene una **inteligencia absolutamente normal**. Su afectación es puramente motora (rigidez, hipotonía, dificultades para caminar). - Solo el **20%** de los pacientes presenta Discapacidad Intelectual asociada.

Características Principales

- **Origen:** Frecuentemente secundario a asfixia perinatal o eventos antenatales. - **Clínica Motora:** Puede presentarse como espasticidad (rigidez), movimientos involuntarios o falta de coordinación. - **Diferenciación:** Es vital no asumir que un paciente con limitaciones físicas o motoras tiene un compromiso intelectual.

Manejo General

El enfoque es de apoyo para maximizar la funcionalidad motora y la integración social, requiriendo kinesioterapia, terapia ocupacional y, en ocasiones, manejo quirúrgico o farmacológico para la espasticidad.

- **Temas relacionados:**
- **Desarrollo Psicomotor**
- **Trastorno del Espectro Autista**
- **Trastorno Bipolar**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Profesora consulta por un niño de 9 años que saca malas notas a pesar de que en clases se comporta muy bien y está tranquilo. Los padres refieren que en casa tarda horas en hacer tareas sencillas y se distrae con cualquier cosa. No hay hiperactividad ni agresividad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Psiquiatría Infantil: TDA e Discapacidad Intelectual. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El TDA tipo hipoactivo pasa desapercibido porque el niño se comporta bien; se detecta por el bajo rendimiento escolar.
- El diagnóstico diferencial del TDA en adultos incluye el episodio maniaco: la manía es aguda con ánimo exaltado, el TDA es crónico desde la infancia.
- El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario.
- La discapacidad intelectual tiene CI menor a 70 como criterio orientador, pero el diagnóstico debe basarse en pruebas de desarrollo completas.
- El 80% de los niños con parálisis cerebral tiene inteligencia normal; la afectación principal es motora, no cognitiva.
- En el TDA el problema es el cambio frecuente del foco atencional, no la ausencia total de atención.
- El TDA en adultos se manifiesta como bajo rendimiento laboral, impulsividad, desorden y dificultades interpersonales.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PSIQUIATRÍA INFANTIL: TDA E DISCAPACIDAD INTELECTUAL)

PREGUNTA 1

Profesora consulta por un niño de 9 años que saca malas notas a pesar de que en clases se comporta muy bien y está tranquilo. Los padres refieren que en casa tarda horas en hacer tareas sencillas y se distrae con cualquier cosa. No hay hiperactividad ni agresividad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Trastorno de conducta disocial
- B)** Trastorno por déficit atencional tipo hiperactivo
- C)** Trastorno por déficit atencional tipo hipoactivo
- D)** Discapacidad intelectual leve
- E)** Depresión infantil

PREGUNTA 2

Hombre de 28 años es derivado por su jefa por bajo rendimiento laboral y múltiples errores en el trabajo. Refiere que desde el colegio siempre fue "despistado" y que en la universidad también tuvo que repetir ramos por problemas de concentración. Es muy impulsivo y desordenado. No hay síntomas afectivos ni psicóticos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Trastorno bipolar en fase hipomaniaca
- B)** Trastorno por déficit atencional en adulto
- C)** Trastorno de personalidad antisocial
- D)** Esquizofrenia residual
- E)** Trastorno adaptativo por estrés laboral

PREGUNTA 3

Niño de 5 años es traído por sus padres porque "no habla bien", tiene dificultades para caminar y usa silla de ruedas. La evaluación neuropsicológica muestra un CI de 95. Los padres preguntan si su hijo tiene retraso mental. ¿Cuál es la respuesta más adecuada?

- A)** Sí, tiene discapacidad intelectual por su dificultad para hablar
- B)** Sí, toda parálisis cerebral se asocia a discapacidad intelectual
- C)** No, la parálisis cerebral afecta principalmente la motricidad; el 80% tiene inteligencia normal
- D)** El diagnóstico de discapacidad intelectual requiere esperar a los 10 años
- E)** El CI de 95 descarta toda patología del neurodesarrollo

RESUMEN: PSIQUIATRÍA INFANTIL: TDA E DISCAPACIDAD INTELECTUAL

El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar. Se presenta en dos formas clínicas: el tipo hiperactivo, más fácil de identificar por la inquietud motora, la verborrea y la impulsividad; y el tipo hipoactivo, que frecuentemente pasa desapercibido ya que el niño se comporta bien pero su rendimiento académico es bajo por la incapacidad de concentrarse sostenidamente. El diagnóstico suele realizarse en la edad escolar cuando las demandas académicas evidencian las dificultades. En adultos, el TDA persiste con las mismas características pero se manifiesta como bajo rendimiento laboral, mayor impulsividad, desorden y eventualmente problemas interpersonales. Es fundamental no confundirlo con un episodio maniaco del trastorno bipolar, ya que la manía es aguda y viene con ánimo exaltado, mientras que el TDA es crónico desde la infancia. El tratamiento del TDA es fundamentalmente multidisciplinario, enfocado en técnicas de estudio, manejo de autoestima, desarrollo de la tolerancia a la frustración y el autocontrol. Los fármacos son un apoyo complementario y no el eje principal del manejo. Los estimulantes más usados son el metilfenidato, las anfetaminas y el modafinilo. El abordaje es el mismo en niños y adultos. La discapacidad intelectual (antes llamada retraso mental) es una entidad diferente, causada por múltiples etiologías (genéticas, hipoxia perinatal, infecciones TORCH, etc.). El diagnóstico se basa en pruebas de desarrollo y cognitivas, siendo el coeficiente intelectual (CI) menor a 70 un indicador orientador, aunque no suficiente por sí solo. Requiere manejo multidisciplinario con estimulación dirigida. Es importante distinguirla de la parálisis cerebral, que en el 80% de los casos cursa con inteligencia normal, afectando principalmente la motricidad.